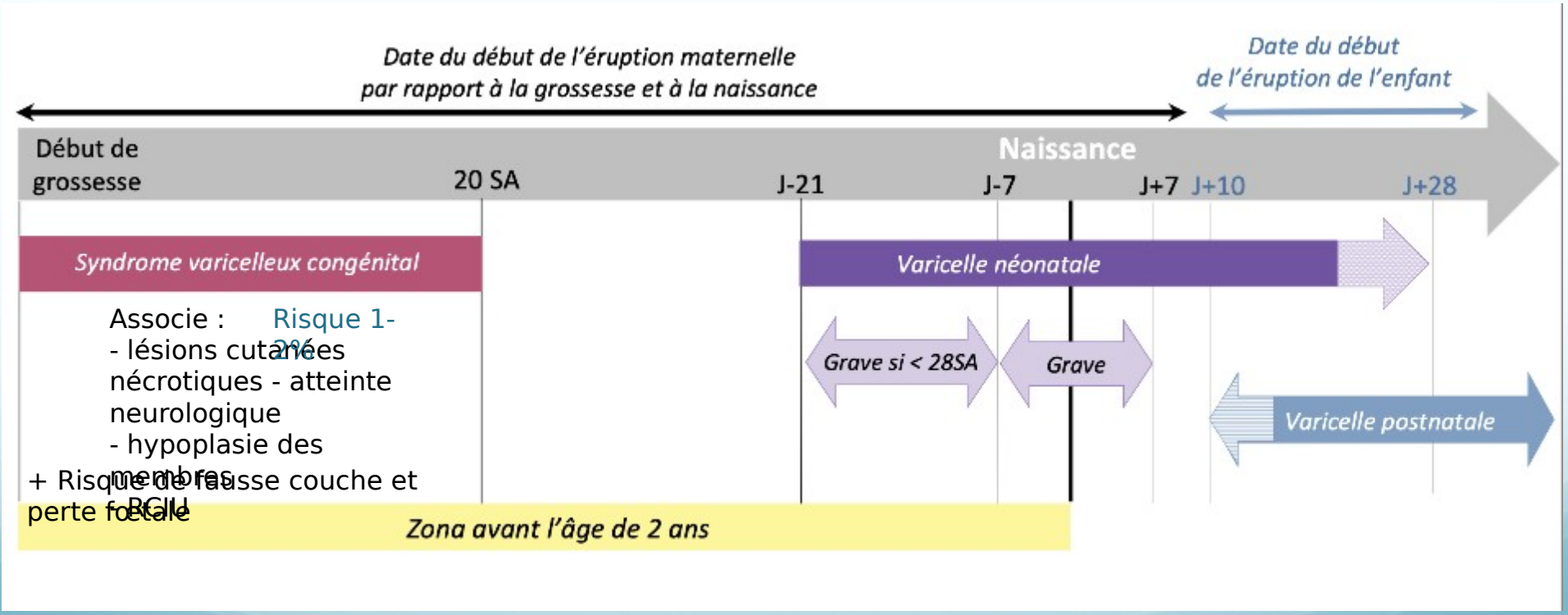
Prévention et prise en charge infectiologique de l'infection par le VZV chez la femme enceinte et en périnatalité

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF le 5 juin 2024

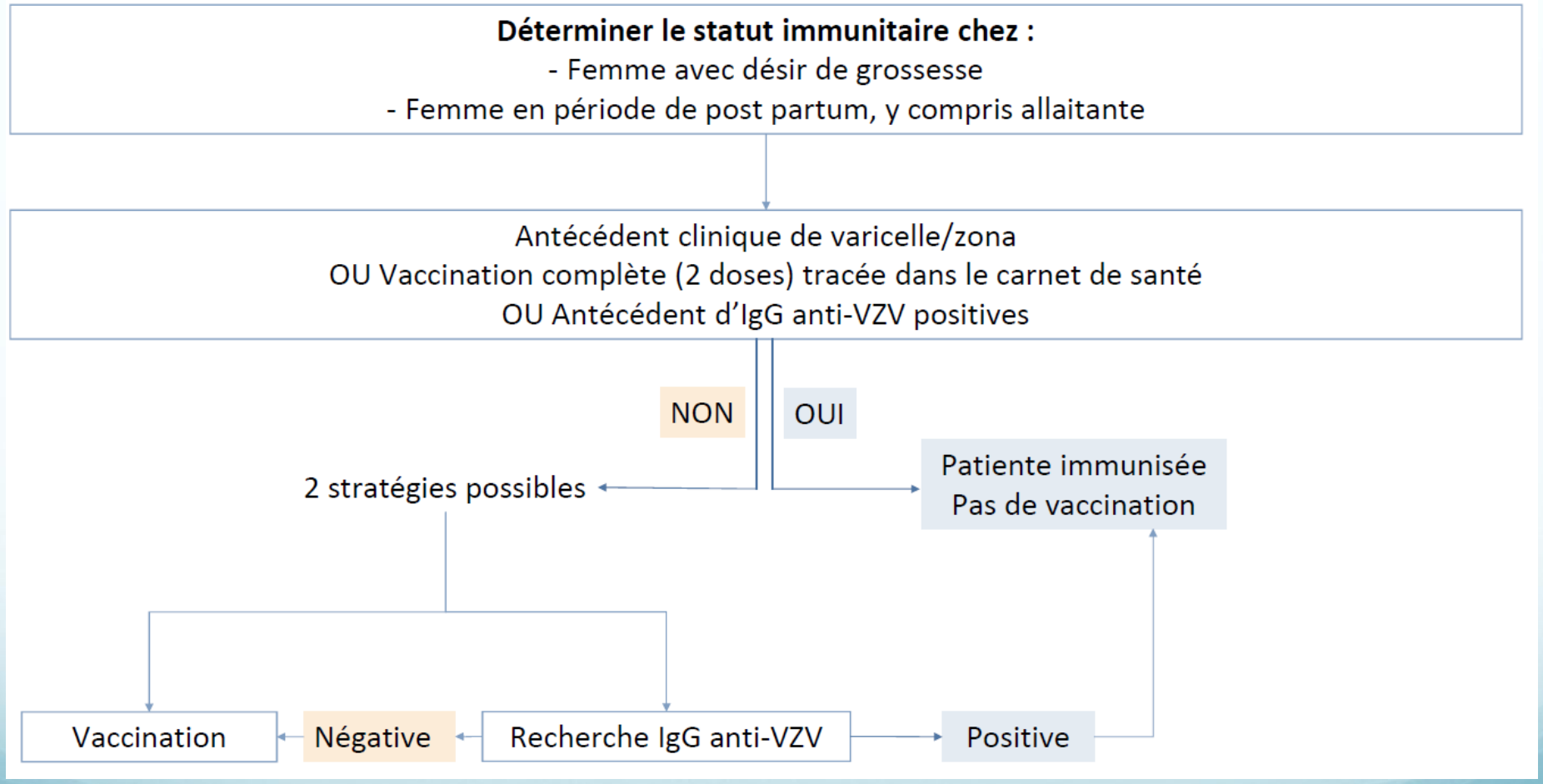
Risques d'une varicelle chez la femme enceinte

- Pour la mère : risque accru de varicelle grave

- Pour le fœtus/nouveau-né : risque fonction de la date de l'éruption maternelle par rapport à la conception et la naissance



Prévention de l'infection par le VZV
avant et après la grossesse



Séroprévalence	> 95%	80%	60 %

Vérifier le statut vis-à-vis du VZV de l'entourage de plus de 12 ans d'une patiente non immunisée

Vaccination Varicelle

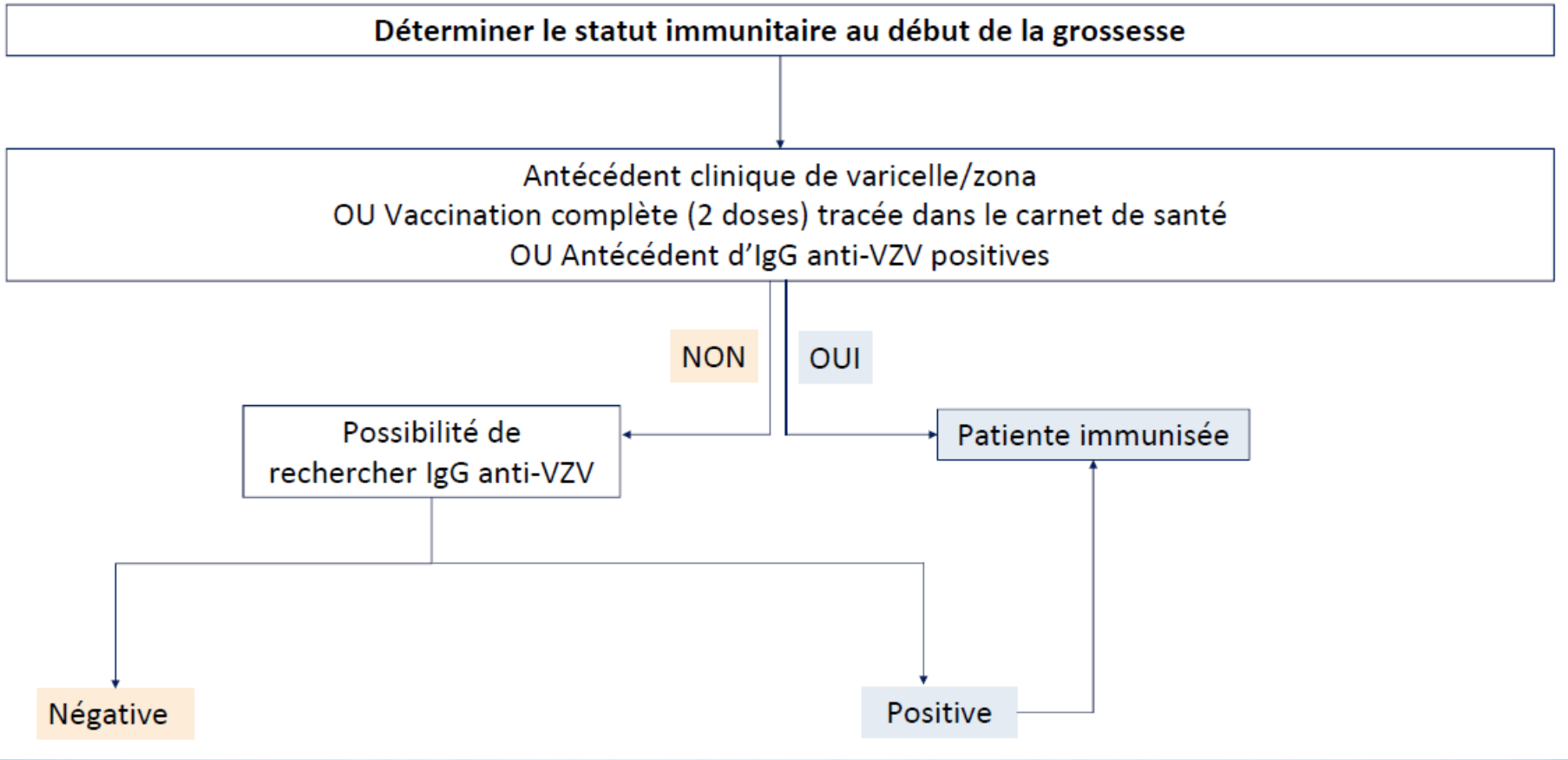
- Schéma vaccinal :
  - VARILRIX® ou VARIVAX®
  - 2 doses à minimum 4 semaines d'intervalle
  - Vaccins interchangeables

- Contre-indications principales :
  - Grossesse
  - Immunodépression

- Respecter un intervalle d'un mois après la seconde dose avant de débuter une grossesse

- En post-partum : respecter un délai de 5 mois par rapport à la réalisation d'une transfusion sanguine ou l'administration d'Ig polyvalentes ou d'immunoglobulines anti-VZV (VZIG).
  L'administration d'Ig anti-RH1 (anti-D) ne justifie pas de report

Prévention de l'infection par le VZV pendant la grossesse



Vaccination contre indiquée pendant la grossesse
Conseils de prévention : éviter les contacts à risque et avis médical sans délai en cas de contage
Rattrapage vaccinal en *post partum*

Vérifier le statut vis-à-vis du VZV de l'entourage de plus de 12 ans d'une patiente non immunisée

Conduite à tenir en cas de contact avec le VZV chez une femme enceinte - 1

1. Le contact est-il à risque ?

Contact
- Au sein du foyer OU sans masque > 1 heure dans la même pièce OU > 5 minutes face à face
- Avec un sujet contagieux porteur d'une varicelle ou d'un zona soit étendu soit survenant dans un contexte d'immunodépression (de 48 heures avant l'éruption cutanée jusqu'au remplacement complet des vésicules par des croutes)

NON → Pas de prophylaxie

OUI

2. La patiente est-elle immunisée ?

Patiente immunocompétente avec
- Histoire clinique de varicelle ou de zona
- OU Vaccination complète (2 doses) tracée dans le carnet de santé
- OU Antécédent d'IgG anti-VZV positives

OUI → Pas de prophylaxie

NON → Vaccination anti-varicelleuse post exposition contre-indiquée pendant la grossesse

Conduite à tenir en cas de contact avec le VZV chez une femme enceinte - 2

3. De quand date le contage ?

Contage ≤ 14 jours

Sérologie dans les 10 j post contage : recherche d' IgG anti-VZV positives ?

OUI → Pas de prophylaxie

NON = IgG négatives ou sérologie non rapidement disponible

Contage ≤ 10 jours

Immunoglobulines anti-VZV IV
0.5-1ml (12-25U)/kg dès que possible
et au maximum 10 jours après contage

10 jours < Contage ≤ 14 jours

Discuter Valaciclovir PO hors AMM
1gx 3/j pendant 7j

Contage > 14 jours

Informer la patiente
- du risque d'échec
- de la CAT si fièvre ou éruptio

+ Vaccination en post-partu

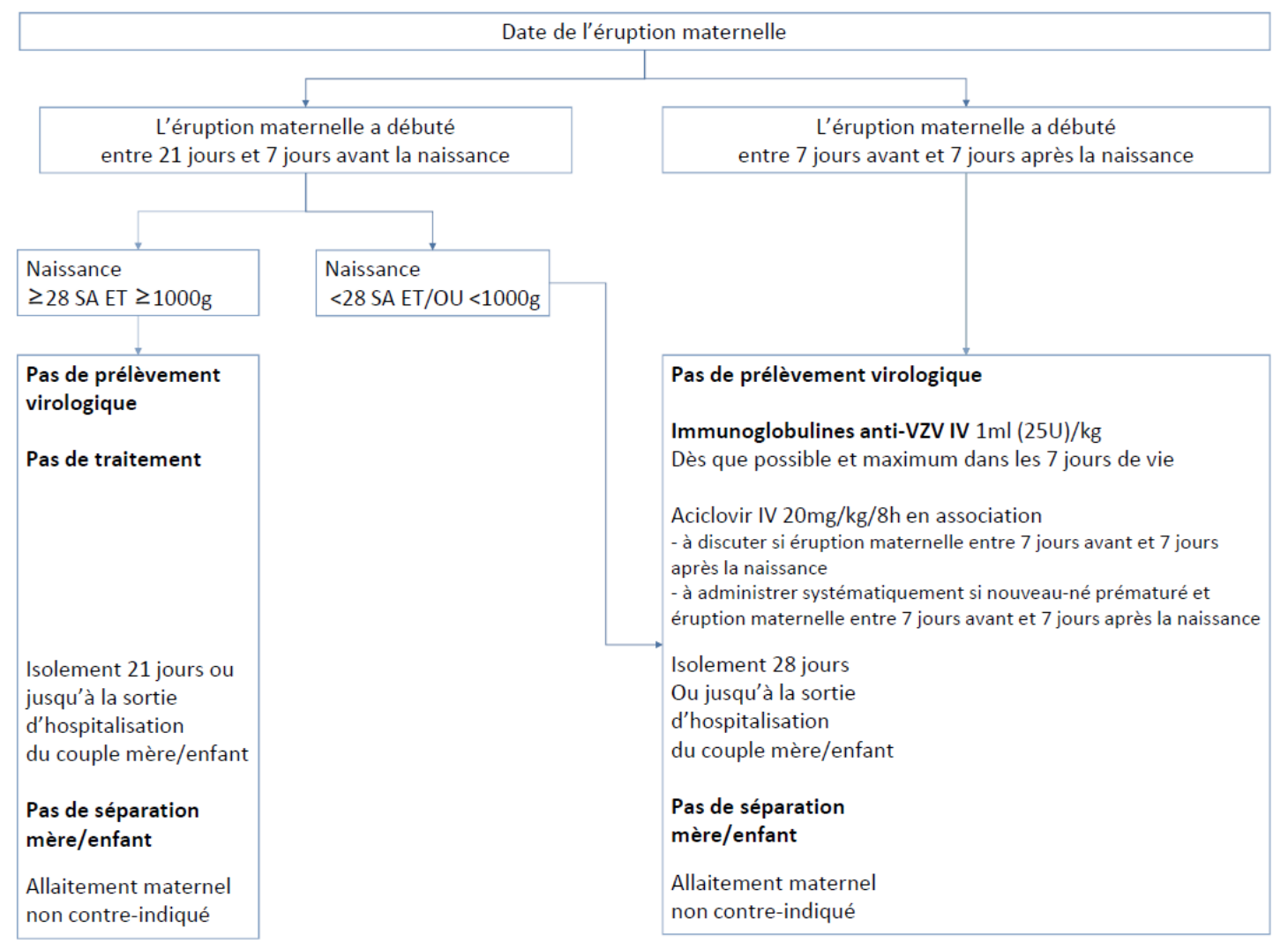
Antiviral oral hors AMM à discuter seulement si :
- Indisponibilité des Ig anti-VZV
- OU contre-indication Ig anti-VZV
(hypersensibilité/déficit sélectif connu en IgA avec anticorps anti-IgA)

Valaciclovir à débuter APRES les 7 premiers jours de contage (maximum 14 jours après)

Prise en charge d'un nouveau-né exposé à une varicelle maternelle moins de 3 semaines avant la naissance et jusqu'à 7 jours après

Nouveau-né asymptomatique

Risque de varicelle néona



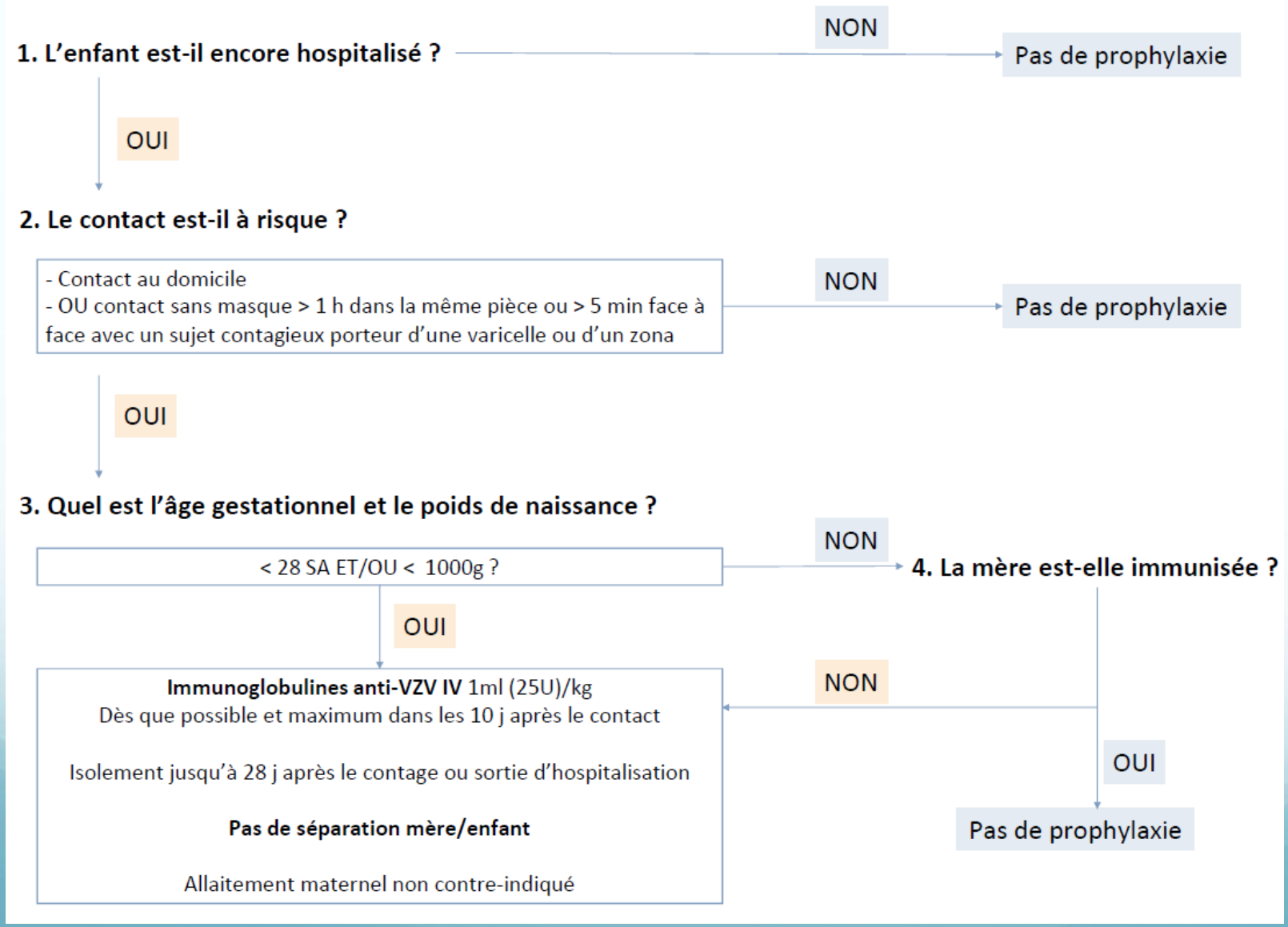
Prise en charge d'un contage postnatal avec le VZV chez le nouveau-né

- Contage postnatal : exposition aérienne ou cutanée directe au VZV
  - Après 7 jours de vie en cas d'exposition au VZV maternel
  - Entre la naissance et le 28ème jour de vie en cas d'exposition non maternelle

- Nouveau-né à risque de varicelle postnatale grave :
  - Nouveau-né encore hospitalisé
  ET
  - Né avant 28 SA ET/OU pesant moins de 1000 g, quelque soit le statut maternel
  - OU né après 28 SA ET pesant moins de 1000 g, de mère non immunisée

Prise en charge d'un contage post-natal avec le VZV chez le nouveau-né

Risque de varicelle postn

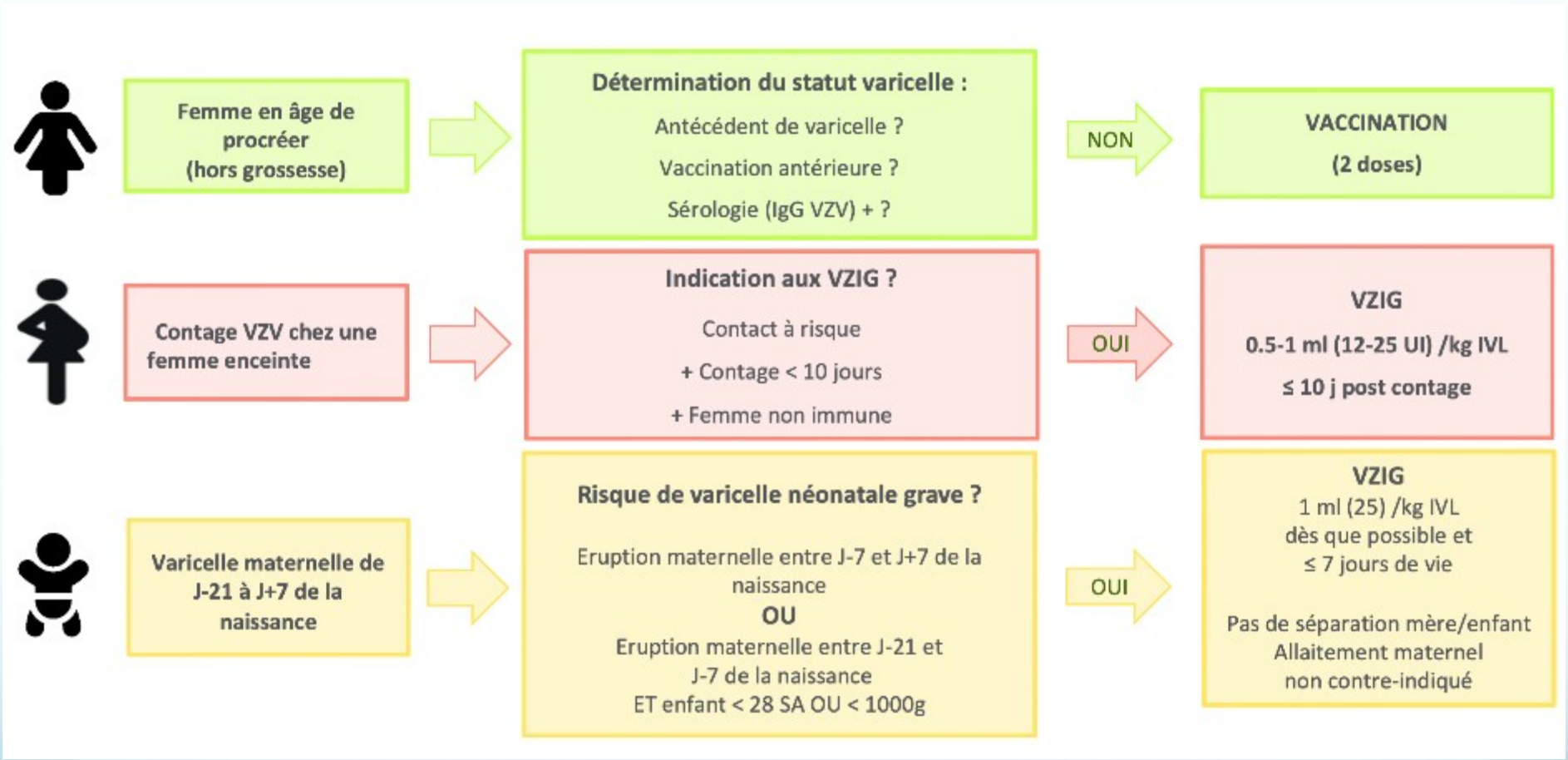


Conduite à tenir pour le nouveau-né d'une mère présentant un zona

- Zona maternel guéri à l'accouchement :
  Aucune surveillance fœtale ni néonatale

- Zona maternel non guéri à l'accouchement :
  - Couvrir les lésions maternelles
  - Allaitement maternel non-contre-indiqué, le contact avec les lésions cutanées sur le mamelon devant néanmoins être évitées
  - Avis spécialisé en cas de :
    - zona chez une patiente immunodéprimée
    - exposition postnatale à des lésions non cicatrisées chez un nouveau-né avant 28 SA ou pesant moins de 1000 g.

Points clés



- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38311003/
- Délai d'application : 5 ans

Quizz – vrai ou faux

- Le risque de syndrome varicelleux congénital est maximal lorsque l'infection maternelle survient entre 20 et 30 SA ?
- Le délai maximal d'administration des Ig anti-VZV chez une femme enceinte non immunisée pour le VZV après contage à risque est de 5 jours ?
- L'aciclovir po peut se discuter en cas de contage à risque survenant entre 10 et 14 jours chez une femme enceinte non immunisée pour le VZV?
- Un nouveau-né prématuré pour lequel l'éruption maternelle est survenu 3 jours avant la naissance doit bénéficier d'Ig anti-VZV et d'aciclovir IV ?
- Un nouveau-né, né à terme, rentré au domicile à J3, exposé à un contage fraternel à J5, doit bénéficier d'Ig anti-VZV si sa mère n'est pas immunisée ?

Quizz – vrai ou faux

- Le risque de syndrome varicelleux congénital est maximal lorsque l'infection maternelle survient entre 20 et 30 SA *Faux : ce risque est maximal lorsque l'infection maternelle survient entre le début de la grossesse et 20 SA*

- Le délai maximal d'administration des Ig anti-VZV chez une femme enceinte non immunisée pour le VZV après contage à risque est de 5 jours ? *Faux : le délai maximal est de 10 jours*

- L'aciclovir po peut se discuter en cas de contage à risque survenant entre 10 et 14 jours chez une femme enceinte non immunisée pour le VZV? *Vrai*

- Un nouveau-né prématuré pour lequel l'éruption maternelle est survenu 3 jours avant la naissance doit bénéficier d'Ig anti-VZV et d'aciclovir IV ? *Vrai*

- Un nouveau-né, né à terme, rentré au domicile à J3, exposé à un contage fraternel à J5, doit bénéficier d'Ig anti-VZV si sa mère